

Дивертикул уретры — это небольшой **карман или мешочек**, образующийся у уретры (мочеиспускательного канала), почти всегда у женщин. В кармане скапливается моча, что вызывает подтекание, дискомфорт, инфекции или боль при половом акте. Состояние часто не выявляется годами, однако хорошо поддаётся лечению.

Об этом состоянии

Классические признаки — “три Д”:

- **Дриблинг** — подтекание мочи сразу после мочеиспускания
- **Дизурия** — жжение или дискомфорт при мочеиспускании
- **Диспареуния** — боль при половом акте

Другие проявления: **повторяющиеся инфекции мочевыводящих путей (UTI)**, ургентность или учащённое мочеиспускание, болезненное уплотнение на передней стенке влагалища, выделяющее жидкость при надавливании.

Причины

Предполагается, что дивертикул формируется, когда небольшие железы вокруг уретры **закупориваются и воспаляются**, а затем вскрываются в просвет уретры, оставляя карман, заполняемый мочой. Это не рак и не связано с вашими действиями.

ТЕРМИНЫ

Уретра

Трубка, выводящая мочу из организма.

Дивертикул

Карман или выпячивание стенки полого органа.

“З Д”

Дриблинг, дизурия (жжение) и диспареуния (боль при сексе).

MRI

Лучшее исследование для оценки кармана перед операцией.

Дивертикулэктомия

Операция по удалению кармана и восстановлению уретры.

Лоскут Мартиуса

Небольшой тканевой лоскут для укрепления шва уретры.

Цистоскопия

Осмотр уретры и мочевого пузыря тонкой камерой.

НУЖНА ЛИ МНЕ ОПЕРАЦИЯ? Не всегда. Небольшой бессимптомный карман можно наблюдать. Но если он вызывает подтекание, инфекции, боль или беспокоящее уплотнение, дивертикулэктомия устраняет проблему радикально. Хирург предварительно точно оценит карман с помощью MRI.

Как это диагностируют

- Осмотр — болезненное уплотнение на передней стенке влагалища, выделяющее жидкость при надавливании
- **MRI** — лучший метод для определения размера и формы кармана
- Иногда — **цистоскопия** для осмотра устья дивертикула изнутри

Как это лечат

- 1 **Наблюдение** при маленьком бессимптомном кармане.
- 2 **Лечение инфекции**, если она есть.
- 3 **Дивертикулэктомия** — вагинальный доступ для удаления кармана и послойного восстановления уретры, иногда с использованием тканевого лоскута.
- 4 **Катетер** оставляется на период заживления; обычно перед его удалением выполняется **контрольная рентгенография**.

Важно знать

- Восстановление требует аккуратности — рассчитывайте на ношение катетера в течение пары недель.
- Большинство пациенток достигают отличного результата; в редких случаях карман может рецидивировать или появляется новое подтекание — это поддаётся лечению.
- Операцию обычно планируют после стихания инфекции.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры, озноб или усиление боли в малом тазу
- Вы **не можете помочиться** или катетер перестал дренировать (после операции)
- Обильное кровотечение или новое постоянное подтекание мочи

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Дивертикул уретры — карман у уретры; помните о “3 Д” (подтекание, жжение, боль при сексе) и повторяющихся UTI.
2. MRI лучше всего визуализирует карман. Маленькие бессимптомные карманы наблюдают; беспокоящие удаляют с тщательным восстановлением уретры.
3. После операции ожидайте катетер и контрольную рентгенографию. Обращайтесь при температуре, невозможности помочиться или новом постоянном подтекании.